

Información Paciente

Nombre : Odilia De Lourdes Urtubia Verdugo
Edad : 64a 10m 26d
Dirección : Puancho 1566

Rut : 8.186.009-2
Fecha Nacto: 27/02/1961
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : A565683
Sexo : Femenino
Teléfono : 967472750

N° Epicrisis
469612

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Unidad Intermedio Coronaria
Unidad de Egreso : Medicina Agudos (4tp Piso)

Fecha Ingreso : 31/12/2025 11:40
Fecha Egreso : 22/01/2026 12:01

Días Estadía: 22

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

síndrome febril

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS

Nombre: Odilia Urtubia Verdugo
Rut: 8186009-2
Edad: 64a
Previsión: Fonasa B
FI SU: 31/12/26
FI UCO 31/12/26
FI UCI: 02/01/26
FRI UTIM: 13/01/26
FI sala: 14/01/26
FE SALA: 22/01/2026

ANTECEDENTES:

Médicos: Fibromialgia, Ca mama (hace 10 años, buen control), HTA, Linfedema brazo izq. Alzheimer, Obs Asma. Hematoma subdural en contexto de TEC.

Quirúrgico: Ca mama izq con linfonodos. Histerectomía total (nódulos, no Ca).

Alergias: No refiere

Medicamentos: Losartan, amlodipino, desloratadina, fluticasona, Salbutamol.

Hospitalizaciones recientes (Abreviada): Paciente presenta caída a nivel hace app 1 semanas, golpeándose la cabeza en dicha oportunidad acude SU TAC sin lesiones agudas.

Social: Puente alto, Autovalente de actividades básicas de la vida diaria, asistencia moderada de actividades instrumentales.

HISTORIA DE INGRESO

Paciente con los antecedentes descritos, consulta el 31/12/25 en SU CASR por historia de una semana de evolución de otalgia bilateral. Además, el día previo a su ingreso los acompañantes la perciben somnolienta y con desorientación. Asociado a esto presentó odinofagia y compromiso del estado general.

El día de la consulta inicia diarreas hasta en 3 ocasiones (sin elementos patológicos), además un vómito con tinte hemático mal precisado. Niega melena, sin síntomas irritativos genitourinarios, sensación febril.

Fecha Epicrisis : 22/01/2026 12:48

Fecha Última Actualización: 22-01-2026 12:48:04

Página 2 de 5

A su examen físico de ingreso destaca somnolencia, hidratación límite y lesión en mano derecha con salida de contenido y aumento de volumen con dolor a la movilización activa y pasiva de la articulación

Se profundiza estudio con TC TAP que muestra posible proceso inflamatorio-infeccioso pulmonar obs. Aspirativo y proceso mal definido a nivel renal bilateral. En exámenes generales destaca, PPII elevados, AKI, compromiso de función hepática, lipasa negativa, láctico elevado evolucionando con req. De DVA, compatible con shock séptico, se volemo con 3 lt y se tituló NAD hasta 0.3, respondiendo favorablemente de la hemodinamia, pero persistiendo compromiso de conciencia, se Pancultiva, OC no inflamatoria, se solicita PL que se concreta sin complicaciones, se extiende cobertura meníngea empírica. Inicia con CNAF, pero por mala respuesta se inicia VMI previo a traslado a UCO.

Dado sin disponibilidad de cama de intermedio médico, se traslada transitoriamente al intermedio coronario para continuar manejo.

DIAGNOSTICOS DE INGRESO

1. Compromiso de conciencia en estudio.

-Obs meningitis

2. NAC

-Obs aspirativa

3. Shock séptico

-foco en estudio

4. AKI

5. Disfunción hepática.

6. Antecedentes: Fibromialgia, Ca mama (hace 10 años, buen control), HTA, Linfedema brazo izq. Alzheimer, Obs Asma. Hematoma subdural en contexto de TEC.

EVOLUCIÓN POR PLANES

- HDN: Ingres a con hemodinamia inestable, ingresa a UCO (por disposición cama) con necesidad de doble vasoactivos para sostener PAM 70. Evoluciona de forma favorable logrando suspensión de DVA el 07/01, bien tolerado. Se le inician VDO el 09/01 por HTA, es trasladada a UTIM y luego a sala estable HDN, no presento quiebre clínico. Al destete de las DVA se comporta con leve HTA que se maneja con ajuste de tratamiento antiHTA de forma favorable. Se desinva durante estadía en UTIM. Al momento del alta en buenas condiciones generales, estable HDN, sin conflicto.

- VENTILATORIO: Ingres a con insuficiencia respiratoria aguda parcial. En la Urgencia describen que protegía vía aérea, por lo que se apoyó inicialmente con CNAF 40/40.

Al ingreso se realice TAC con imagen de probable neumonía aspirativa. Evoluciona en peores condiciones generales, en contexto de shock, se decide VMI al momento del traslado a UCO el día 02/0. Evoluciona de forma favorable siendo extubada el 09/01 con paso a CNAF, hasta el 12/01 que se traslapa a oxígeno por naricera hasta 3lts, con saturaciones óptimas. Durante UTIM sin nueva insuficiencia respiratoria. En sala se logra destetar de O2 suplementario. Al alta normosaturan con O2 ambiental.

- INFECCIO: ingresa con cuadro compatible con shock séptico de origen desconocido. Respecto estudio, imagen compatible con NAC obs aspirativa. Foco meníngeo descartado (LCR negativo). Además lesión de piel y partes blandas, con puerta de entrada en mano derecha, con TAC de mano sin compromiso óseo/articular, ni signos de fascitis necrotizante.

Durante su estadía se mantiene con Meropenem + Vancomicina dado sepsis de sospecha de foco cutáneo/pulmonar, sin lograr aislar microorganismo, completa tratamiento el 09/01, con mejoría clínica y con PPI a la baja. Es trasladada a sala sin nuevo foco infeccioso. El día 18/01 presenta peak febril, por lo que se pancultiva y se inicia nuevamente Meropenem. Se encuentra foco infeccioso urinario, con una E. Coli MS. Se desacala a ceftriaxona para completar 5 días de tratamiento, PPI a la baja del alta, tratamiento completado en hospitalización. Al momento del alta se encuentra afebril, normocárdica, sin quiebre clínico. Al examen de laboratorio, solo destaca una trombocitosis que apareció durante la hospitalización, lo cual se asocia a proceso inflamatorio actual.

Pendiente rescatar examen de Bartonella/Toxocara. (no disponibles al alta)

Dermatología:

Presento una reacción alérgica luego del 2do inicio de meropenem, asociado a persistencia de patrón colestásico y hipeosinofilia, se propone un síndrome de DRESS leve VS RAM, sin daño de órgano. Se suspende meropenem el día 20/01 y se realiza decalae a ceftriaxona. Se deja control al alta. Sin compromiso de órgano al alta, e hipereosinofilia menos de 500.

Fecha Epicrisis : 22/01/2026 12:48

Página 2 de 5

- RENAL: ingresa con AKI KDIGO I, con acidosis metabólica, sin trastorno hidroelectrolítico asociado, con buena respuesta a volemicización, sin criterios de TRR durante hospitalización. Evoluciona de forma favorable con resolución de falla renal y del resto de trastornos mencionados. Sin conflicto de momento.

- GASTRO: ingresa con pruebas hepáticas alteradas, las cuales se han mantenido estacionariamente alteradas el perfil hepático se caracteriza por tener un patrón colestásico. Se mantiene patrón colestásico, con leve hipereosinofilia. Al momento del alta en descenso. Se solicita ecografía abdominal, que no se logra realizar. Se continuara estudio ambulatorio

- Nutrición: durante su estadía en UCI se mantiene con nutrición enteral con Diben 1.5, en meta, bien tolerado. Sin hiperglicemias, que requiera Insulina correccional. Desde la extubación, paciente se comporta disfónica y con mala deglución, en seguimiento por fonaudiológica. Se realiza nasofibroscopia por parte del equipo de OTL, e impresioan conflicto mecanico de la SNG con la orofaringe. Se procese a su retiro, luego paciente logra fonar y poder deglutir con dificultar pero evoluciona de forma favorable. Al momento del alta con ingesta oral y pudiendo comunicarse de forma verbal.

-Cuidados: paciente presenta dos lesiones por presión al momento del ingreso a sala, las dos en grado II. Se realizan curaciones por parte del equipo de enfermería, con buena evolución. Al momento del alta, con alta por parte de enfermería. Se indica loción de losiones especidicado en indeicaciones. Paciente al alta en su estado basal, con demencia tipo alzheimer.

MICROBIOLOGÍA

12/01: IgG toxocara y Bartonella (p)

09/01: PCR HS/VVZ (-)

07/01: Cultivo de secrecion de mano derecha: (+) Escaso S. Epidermidis y E. Faecium Van B

05/01: Cultivo de LCR (-)

02/01: UC: (-)

IMÁGENES

TAC mano derecha 02/01: Engrosamiento cutáneo y acentuado edema en tejido subcutáneo con predominio en el dorso de la mano sin identificar colecciones ni burbujas de gas categóricas que sugieran una fascitis necrotizante.

TAC AP CC 31/12: Tenues opacidades de relleno alveolar en el lóbulo inferior derecho que podrían ser de origen inflamatorio infeccioso. Considerar componente aspirativo. Dudosa alteración bilateral del nefrograma, inespecífica.

22/01

Albumina: 3.4

FA 151 GGT: 410

GOT: 22 GPT: 24

Ca: 9.4

Crea: 0.53 BUN: 22.5

PCR: 4.5

Hb: 11 Htco: 33.4 VCM: 91.9 Leuco: 3.43 Eosinófilos: 490 absoluto PQL: 636

ELP: 144/3.57/108

20/01

Fierro: 36 TIBC: 243 Sat: 15

Ferritina 318

DIAGNÓSTICOS AL ALTA

1. Shock septico resuelto

- NAC: obs. aspirativo sin microbiología

-- Celulitis mano derecha

2. AKI KDGO 1 resuelto// hipernatemia VEC euvolemico resuelta

3. Disfonia resuelto
4. RAM vs Sd. DRESS leve
 - Hipereosinofilia leve, patrón colestasico, rash dermatologico.
5. ITU alta tratada
 - E. Coli MS
6. Antecedentes: Alzheimer, Fibromialgia, Ca mama (hace 10 años, buen control), HTA, Linfedema brazo izq. , Obs Asma. Hematoma subdural en contexto de TEC.

Diagnóstico de Egreso

Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Estable hemodinamicamente, normotensa, normocardica. Saturación optima con O2 ambiental, afebril.

Vigil espontanea, desorientada tiempo y espacio, inatenta, cooperadora.

Diuresis +

Deposiciones +

Ingesta oral + (regimen fono)

Plan Post Alta

Indicaciones

GENERALES

Regimen común según plan de fonaudiología.

-Régimen blando

-Líquidos claros con bombilla en sorbos pausados

-Dar alimentación e hidratación: Sentada, asistida, pausada.Mentón al pecho Cuchara no llena y esperar que ingiera total de contenido, antes de recibir siguiente porción.

Hidratación abundante con agua. Recordar tomar agua cada 4-6 horas.

- Levantar dentro de lo posible, para evitar estar todo el día en cama.

- Ayudar en orientación(poner calendario, objetos familiares)

- Cuidado de piel: en las dos lesiones que presenta en la zona sacra(espaldada) colocar crema Aloe Vera 2-3 veces al día. En caso de mala progresión, acudir a CESFAM para solicitar hora a cuidados de lesiones por enfermería.

MEDICAMENTOS

Moles medicamentos y dar en conjunto a compota de fruta.

Losartán 50mg. 1 comprimido cada 12 horas vía oral

Amlodipino 10mg. 1 comprimido cada 24 hora vía oral

Carvedilol 25mg. Medio comprimido cada 12 horas vía oral

Furosemida 20mg. 1 comprimido cada 12 horas vía oral

Medicamentos SOS

Paracetamol 500mg. 2 comprimidos cada 8 horas . En caso de dolor.

Clorfenamina 4mg cada 12 horas (En caso de persistir picazon)

Polietilglicol 15 gr en 250cc de agua. Dar una vez al día en caso de no lograr deposiciones.

CONTROLES

Contro en CESFAM ambulatorio correspondiente. Control con medico y revisión de exámenes Por favor. (Función renal, ELP, hemograma). Solicitar perfil de hierro por favor.

Consultar al servicio de urgencia en caso de: nauseas o vomitos que impidan ingesta oral, fiebre más de 48 horas, compromiso de conciencia, o cuando estime conveniente.

Indicaciones

Fecha Epicrisis : 22/01/2026 12:48

Página 4 de 5



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL
DR. SÓTERO DEL RÍO
JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 22-01-2026 12:48:04

Página 5 de 5

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Esquema Entregado En Epicrisis.

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Lucas Ignacio Tortello Brito

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 22/01/2026 12:48

Página 5 de 5

Fecha de Impresión : Jueves, 26 de Marzo de 2026 00:01

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar